



บัญชีรายการความเสี่ยง (Risk Profile)
โรงพยาบาลดอนตูม ประจำปี 2569

ความเสี่ยงด้านคลินิก (Clinical Risk)

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่ (1-5)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (1-5)	ผลคูณ (1-25)	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม/ป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง
1	ผู้ป่วย STEMI เข้าถึงการวินิจฉัย การให้ยา และการส่งต่อไม่ทันเวลามาตรฐาน ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง	4	5	20		1. ใช้ STEMI Fast Track และ Standing Order สำหรับผู้ป่วย Chest Pain 2. ตรวจ ECG และ Trop T ตั้งแต่จุดคัดแยก พร้อมบันทึกเวลาในทุกขั้นตอน 3. ใช้ Teleconsult ประสานเครือข่ายส่งต่อ และ EMS pre-notification 4. ทบทวนผู้ป่วยทุกรายที่ล่าช้าหรือเกิด cardiogenic shock
2	ผู้ป่วย Stroke เข้าถึงโรงพยาบาล ส่งต่อ และได้รับ rTPA ไม่ทันตามมาตรฐาน	4	5	20		1. ใช้ Stroke Fast Track และ Stroke Protocol พร้อมประเมิน FAST 2. ใช้ EMS pre-notification, TeleStroke และประสานเครือข่ายส่งต่อ 3. ติดตามเวลา Onset-to-hospital, Door-to-refer และ Door-to-rTPA 4. ทบทวนกรณีล่าช้าและปรับ pathway ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่าย
3	หญิงคลอดเกิด PPH และหญิงตั้งครรภ์ความดันสูงรุนแรงเพิ่มขึ้น เสี่ยงต่อการส่งต่อล่าช้าและการเสียชีวิตมารดา	4	5	20		1. คัดกรองความเสี่ยง PPH/ANC และจัดทำแผนส่งต่อรายบุคคล 2. ใช้ PPH Bundle ฝ้าระวัง 2 ชั่วโมง ตรวจรกโดยเจ้าหน้าที่ 2 คน และเตรียมยา/เลือด 3. กำหนดเกณฑ์ส่งต่อก่อนคลอดสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มี severe hypertension 4. ซ้อม Massive PPH และทำ RCA ทุกกรณีที่มีความรุนแรง
4	ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคัดแยกต่ำกว่าความรุนแรงจริง หรือการประเมินแรกไม่ครบถ้วน ทำให้การรักษาและเปิด Fast Track ล่าช้า	4	4	16		1. ใช้เกณฑ์ MOPH ED Triage/ESI และระบบ Early Warning Score 2. ทบทวนสมรรถนะผู้คัดแยกและตรวจประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละเวร 3. ใช้ Trigger Tool และ Standing Order สำหรับโรคสำคัญ 4. ทำ RCA เหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไปให้ครบถ้วนร้อยละ 100

5	ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุและโรคเรื้อรังกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำ จากการวางแผนจำหน่ายและติดตามต่อเนื่องไม่เพียงพอ	4	4	16		1. จัดทำ Discharge Planning และ Medication Reconciliation 2. ประเมินความเสี่ยงก่อนจำหน่ายและใช้ Teach-back กับผู้ป่วย/ญาติ 3. โทรติดตามภายใน 48–72 ชั่วโมง และเชื่อมต่อระบบ HHC/LTC 4. มอบหมาย Care Coordinator และทำ Case Conference ในผู้ป่วยที่กลับมานอนซ้ำ
6	ผู้ป่วย COPD เกิดภาวะกำเริบเฉียบพลันสูงกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้เข้ารับบริการฉุกเฉินหรือนอนโรงพยาบาลซ้ำ	4	4	16		1. จัดบริการ COPD Clinic และตรวจ Spirometry ตามข้อบ่งชี้ 2. ประเมินและสอนเทคนิคการใช้ยาพ่นทุกครั้ง พร้อมทบทวนความร่วมมือในการใช้ยา 3. จัดกลุ่มผู้ป่วยเสี่ยงสูงเพื่อติดตามใกล้ชิด ส่งเสริมวัคซีนและการเลิกบุหรี่ 4. ดำเนินการ Pulmonary Rehabilitation และโทรติดตามหลังจำหน่าย
7	หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ล่าช้าและรับบริการ ANC ไม่ครบ ทำให้ค้นหาความเสี่ยงและป้องกันภาวะแทรกซ้อนไม่ทัน	4	4	16		1. จัดทำทะเบียนหญิงตั้งครรภ์และค้นหาการตั้งครรภ์ระยะแรกผ่านเครือข่าย รพ.สต./อสม. 2. ใช้ระบบแจ้งเตือนนัดและติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่ขาดนัดอย่างต่อเนื่อง 3. มอบหมาย Case Manager และติดตามการรับประทานธาตุเหล็ก/ภาวะซีด 4. ประเมินความเสี่ยงและส่งต่อครรภ์เสี่ยงสูงตามเกณฑ์โดยไม่ล่าช้า
8	เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอนสั่งใช้ คัดลอก จัดเตรียม จ่าย หรือให้ยา โดยเฉพาะผู้ป่วยใน	5	3	15		1. ปฏิบัติตามหลัก 5R/8R และทำ Medication Reconciliation ในช่วงเปลี่ยนผ่านการดูแล 2. ใช้ระบบ Double Check ในยา HAD, LASA และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 3. ใช้ Standard Order Set ลดการคัดลอกคำสั่งยา และให้เภสัชกรทบทวนใบสั่งยา 4. วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนรายชั้นตอน ค้นข้อมูลรายเดือน และติดตามในคณะกรรมการ PTC
9	ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงควบคุมโรคได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนและการนอนโรงพยาบาล	5	3	15		1. ดำเนินงาน NCD Clinic ตาม CPG และจัดทำทะเบียนผู้ป่วยเสี่ยงสูง 2. ใช้ Case Management และเชื่อมข้อมูลกับเครือข่าย รพ.สต./อสม. 3. จัดทำแผน Self-management และติดตามความร่วมมือในการใช้ยา/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 4. ใช้ Telemedicine หรือติดตามเชิงรุกในผู้ป่วยที่ควบคุมโรคไม่ได้

10	ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ได้รับการประเมินหรือส่งต่อไม่ครบตามเกณฑ์	3	5	15		1. ใช้ Head Injury Guideline และประเมิน GCS/Red Flags อย่างครบถ้วน 2. ประเมินซ้ำตามระยะเวลาและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของอาการ 3. ใช้ Teleconsult และประสานการส่งต่อแบบ Real-time เมื่อเข้าเกณฑ์ 4. ทบทวนเวชระเบียนและวิเคราะห์กรณีที่ไม่ได้ส่งต่อตามเกณฑ์
----	--	---	---	----	--	---

ความเสี่ยงด้านทั่วไป (Non-clinical Risk)

ลำดับ	รายการความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่ (1-5)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (1-5)	ผลคูณ (1-25)	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม/ป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง
1	กำลังคนพยาบาลและภาระงาน OPD ไม่สมดุลกับความต้องการบริการ เสี่ยงต่อความเหนื่อยล้าและความผิดพลาด	5	4	20		1. จัดอัตรากำลัง เวิร์ และ OT ให้สัมพันธ์กับปริมาณและความซับซ้อนของงาน 2. จัดทำ Workload Dashboard และแผน Staffing Contingency 3. ปรับกระบวนการบริการ OPD, Cross Training และ Fatigue Management 4. ติดตาม Turnover, Engagement และเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับภาระงาน
2	ระบบน้ำหรือไฟฟ้าไม่พร้อมใช้ กระทบความต่อเนื่องและความปลอดภัยของบริการ	4	4	16		1. บำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบน้ำ ไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามแผน 2. ประเมินกำลังสำรองและจัดให้มีน้ำ/ไฟฟ้าสำรองเพียงพอต่อบริการสำคัญ 3. จัดทำและซ้อมแผน Downtime พร้อมกำหนด SLA ของผู้รับจ้าง 4. ติดตามเหตุไม่พร้อมใช้ ระยะเวลาหยุดชะงัก และผลการดำเนินงาน PM
3	อาคาร พื้นที่บริการ ทางเดิน และห้องน้ำไม่ปลอดภัย/ไม่พร้อมใช้ หรือไม่รองรับผู้พิการ	5	3	15		1. ดำเนินการ Safety Walkround และใช้ระบบแจ้งซ่อมที่ติดตามสถานะได้ 2. จัดทำ Critical Repair List และกำหนด SLA งานซ่อมเร่งด่วน 3. ประเมินการเข้าถึงของผู้พิการและจัดทำแผนที่จุดเสี่ยงซ้ำ 4. รายงานจุดเสี่ยงซ้ำและอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อมต่อผู้บริหารเป็นระยะ
4	ระบบสารสนเทศอาจหยุดชะงัก ถูกเข้าถึงโดยไม่มีสิทธิ์ หรือเกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล	3	5	15		1. ใช้ Access Control ตามบทบาท, Firewall, Antivirus และ Audit Log 2. ใช้ MFA สำรองข้อมูล และทดสอบการกู้คืนข้อมูลตามแผน 3. ดำเนินการตาม PDPA/Privacy Notice และใช้แผนตอบสนองเหตุของ CISO/CSIRT 4. ซ้อม Phishing, Downtime และ Table-top พร้อมติดตาม Uptime/Privacy Breach
5	ข้อมูลเวชระเบียนบางรายการไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	4	3	12		1. ทบทวนเวชระเบียน ตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการ CDI/Coding Review

						2. จัดทำ Data Quality Dashboard รายข้อมูลสำคัญและตั้ง Mandatory Check 3. คืบข้อมูลให้หน่วยงานและทำ RCA ในความผิดพลาดซ้ำหรือข้อมูลซ้ำ 4. ติดตามความครบถ้วน Critical Data Error, Accuracy และ Timeliness
6	เวชภัณฑ์ วัสดุ หรือยาบางรายการหมดอายุ คงคลังคลาดเคลื่อน หรือเสี่ยงขาดแคลนรายการสำคัญ	4	3	12		1. ใช้ระบบทะเบียนคุม หลัก FEFO และกำหนดระดับ Min-Max ของพัสดุ/ยา 2. จัดทำ Critical Item List และระบบแจ้งเตือนรายการใกล้หมดอายุ 3. ตรวจนับแบบ Cycle Count และทบทวนสาเหตุเมื่อยอดคงคลังคลาดเคลื่อน 4. จัดหาแหล่งสำรองหรือผู้ขายทดแทนสำหรับรายการสำคัญ
7	บุคลากรรายงานความเสี่ยงด้วยตนเองต่ำกว่าเป้าหมาย ทำให้องค์กรอาจค้นพบปัญหาและเรียนรู้จากเหตุการณ์ได้ไม่ครบถ้วน	4	3	12		1. ส่งเสริมวัฒนธรรม No Blame No Shame และการรายงานผ่าน HRMS on Cloud 2. จัด Safety Huddle, RM Round, Trigger Tool และ Chart Review เพื่อค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก 3. คืบข้อมูลผลการทบทวนและความคืบหน้ามาตรการแก่ผู้รายงาน/หน่วยงาน 4. ติดตามอัตรา Self Report การปิด Action และเหตุการณ์ซ้ำ พร้อมยกย่องผู้รายงาน
8	เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายไม่พร้อมใช้ ทำให้บริการหยุดชะงักหรือล่าช้า	4	3	12		1. จัดทำทะเบียนและรายการ Critical Equipment/Hardware พร้อมผู้รับผิดชอบ 2. ดำเนินการ PM/Calibration ให้ครบถ้วนตามแผนและติดตามสถานะ 3. จัดอุปกรณ์สำรอง กำหนด SLA ผู้ขาย และใช้ขั้นตอน Downtime 4. ซ้อมแผนหยุดชะงักและติดตาม Network Uptime/ระยะเวลาการแก้ไข

9	อัคคีภัย ภัยพิบัติ หรือลิฟต์ขัดข้องอาจทำให้ผู้ป่วยและบุคลากรไม่สามารถอพยพหรือรับการช่วยเหลือได้ทันเวลา	5	2	10		1. ทบทวน Emergency Codes และแผนบัญชาการเหตุการณ์ของโรงพยาบาล 2. ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุ อุปกรณ์ดับเพลิง เส้นทางหนีไฟ และจุดรวมพล 3. ซ้อม Code Red, Code Green และ Code Brown ครบทุกหน่วยงาน 4. สรุป After Action Review และติดตามการปิดประเด็นปรับปรุงตามกำหนด
10	การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจบางด้านต่ำกว่าเป้าหมาย ส่งผลต่อผลลัพธ์องค์กรและความสำเร็จของแผนพัฒนา	3	3	9		1. ทบทวน Strategic Risk และตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าเป้าหมายในไตรมาส 2. ถ่ายทอด KPI สู่หน่วยงานและกำหนดเจ้าภาพ/แผนปรับปรุงที่ชัดเจน 3. จัดทำ Monthly Dashboard และระบบ Escalation เมื่อผลลัพธ์มีแนวโน้มไม่บรรลุ 4. ดำเนินโครงการ High Impact และติดตามผลลัพธ์รายไตรมาส